

ITEM 274 : LITHIASSE BILIAIRE

Très fréquent = 20%, augmente avec l'âge (60% > 80 ans) : 80% asymptomatique, 20% compliqué (migration dans 1 cas/2)

FdR	Calcul cholestérolique (80%)		Calcul pigmentaire (20%)
	- Age > 60 ans, sexe féminin, multiparité - Surpoids ou variations importantes de poids - Régime hypercalorique, riche en graisse, absence d'activité physique - Jeun prolongé - Antécédents familiaux ou certaines ethnies - Hypertriglycéridémie - Médicament : fibrate, œstrogène - Mucoviscidose, résection iléale → L'hypercholestérolémie sanguine n'est pas un facteur de risque		= Déconjugaison de la bilirubine → insoluble - ↑ Bilirubine : hémolyse chronique, médicaments - Infection des voies biliaires - Obstacle biliaire chronique: sténose bénigne ou maligne de la voie biliaire principale - Cirrhose - Infection parasitaire
Lithiase symptomatique	Colique hépatique	C	- Douleur : brutale, souvent intense, permanente, épigastrique (60%) ou hypocondre droit, inhibant l'inspiration forcée, irradiant vers l'épaule droite ou la fosse lombaire droite - Durée : de quelques minutes à quelques heures (< 6 heures) - Signe de Murphy : douleur inhibant la respiration à la palpation de l'aire vésiculaire
		Bio	- ↑ ASAT/ALAT : ± importante, très fugace → normalisation ou forte diminution en 48h
		Echo	= Référence : plus sensible (95%) que le scanner (lithiase parfois isodense) ou l'IRM - Calcul vésiculaire (même de petite taille = 1 à 2 mm) - Recherche de dilatation de la voie principale et de complications (cholécystite, pancréatite)
Lithiase compliquée	Cholécystite aiguë	= Infection aiguë de la vésicule biliaire due à une obstruction prolongée du canal cystique	
		C	- Syndrome infectieux avec frissons + douleurs de l'hypocondre droit > 24h - Généralement sans ictère (obstruction biliaire associée dans < 10% des cas)
		Bio	- Hyperleucocytose à PNN, ↑ CRP - Rechercher : ↑ ASAT/ALAT ou ↑ GGT, PAL, bilirubine ou ↑ lipase (> 3N) - Hémoculture systématique
		Echo	- Épaississement de la paroi vésiculaire > 4 mm (aspect en triple feuillet) - Sludge : bile épaisse contenant des débris (pus), déclive - Complications : abcès de paroi vésiculaire, épanchement péri-vésiculaire
		Complication	- Péritonite biliaire (perforation vésiculaire) - Syndrome de Mirizzi : compression de la VBP par un calcul vésiculaire volumineux - Fistulisation biliaire dans le duodénum ou le colon → iléus biliaire si volumineux
		DD	- Cholécystite alithiasique (rare) : patient en réanimation avec nutrition parentérale - Autre cause d'épaississement de la paroi vésiculaire : hypertension portale, hépatite...
	Angiocholite aiguë	= Infection aiguë de la voie biliaire principale, généralement par lithiase de l'ampoule de Vater	
		C	- Triade de Charcot = apparition sur 48h : douleur biliaire, fièvre élevée puis ictère - Syndrome infectieux souvent au 1^{er} plan : bactériémie, sepsis, choc septique
		Bio	- Cholestase, ↑ bilirubine, hyperleucocytose à PNN, ↑ transaminase à la phase aiguë - Hémoculture systématique : souvent positives à germe digestif - Complication : IRA fonctionnelle puis organique, thrombopénie septique, pancréatite
		Echo	- Lithiase vésiculaire : évocateur - Dilatation des voies biliaires extra-hépatique et intra-hépatique (cholédoque > 8 mm) - Calcul de la voie biliaire principale : visualisé dans 30 à 50% des cas
		PC	- Scanner abdominal : signes indirects = dilatation de la voie biliaire - Bili-IRM ou écho-endoscopie : mise en évidence de la lithiase de la voie biliaire principale (sensibilité > 90%), rarement réalisable en urgence
		Complication	- Choc septique - Angiocholite ictéro-urémigène : associée à une insuffisance rénale, parfois grave
		Autre cause	- Sténose de la VBP (tumeur du pancréas ou de la VBP) - Parasite (ascaris, douve) - Compression extrinsèque (ADP, pseudokyste de pancréatite chronique...) - CPRE

	Pancréatite aiguë	= Associée ou non à une angiocholite et/ou une cholécystite	
TTT	Calcul vésiculaire asymptomatique	- Aucune indication de traitement dans la majorité des cas - Cholécystectomie si polype vésiculaire > 0,8 cm ou cholécystite chronique	
	Colique hépatique	- Mise à jeun - Antalgie IV : antispasmodique (phloroglucinol), antalgique de palier adapté, AINS - Cholécystectomie réalisée rapidement (< 1 mois) pour éviter la récurrence/complication - Cholangiographie antérograde per-opératoire (recherche de lithiasse de la VBP par injection antérograde via le canal cystique) : non systématique, indiqué en cas d'antécédent de pancréatite, ictère, cytolyse hépatique, cholestase ou dilatation échographique des voies biliaires	
	Cholécystite aiguë	Grade de sévérité	- Grade 1 = gravité faible - Grade 2 = gravité modérée : hyperleucocytose > 18 G/L, masse palpable de l'HCD, durée des symptômes > 72h et/ou infection locale (péritonite biliaire localisée, abcès péri-vésiculaire ou hépatique, cholécystite gangréneuse ou emphysemateuse) → Grade 1 et 2 : cholécystectomie réalisable précocement - Grade 3 = gravité sévère : défaillance viscérale → risque chirurgical élevé : PEC du foyer septique indispensable, préférentiellement par drainage cholédocien percutané
	Angiocholite	→ Hospitalisation en USI ou USC selon l'état de malade - Antibiothérapie large spectre IV par Augmentin® + gentamicine - Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) en urgence absolue : sous AG, désobstruction de la voie biliaire par sphinctérotomie endoscopique biliaire et extraction du calcul → Complication (5-10%) : pancréatite aiguë (1%), hémorragie (1%), perforation (1%), infection - Si non disponible/malade instable : drainage transcutané des voies biliaires sous guidage écho (possible si les voies biliaires intra-hépatiques sont assez dilatées) ou chirurgical par drain de Kehr - Cholécystectomie dans un 2nd temps	
	Calcul de la voie biliaire principale	= Sans angiocholite associée : découverte fortuite ou lors de l'exploration d'anomalies biologique - Désobstruction (sauf sujet âgé) : - Cholécystectomie avec désobstruction per-opératoire - Cholécystectomie puis sphinctérotomie endoscopique biliaire - Sphinctérotomie endoscopique biliaire puis cholécystectomie	
Cas particuliers (rares)	Cholécystite chronique	= Consécutive à une succession de coliques hépatiques/cholécystites non traitées - Vésicule porcelaine = calcifications : diagnostic échographique ou TDM → Risque de dégénérescence en adénocarcinome vésiculaire - Vésicule scléro-atrophique = cicatrisation atrophique : diagnostic écho ou TDM = vésicule épaissie, paroi moulée autour de la lithiasse → risque de dégénérescence en ADK vésiculaire - Calculo-cancer : malignité de la pièce opératoire (1-2%)	
		Fistule bilio-digestive (rare)	- Iléus biliaire = obstruction au niveau de la valvule de Bauhin par une lithiasse : syndrome occlusif, avec aérobilie - Syndrome de Bouveret (rare) : occlusion duodénale par un calcul > 3 cm par fistulisation vésiculo-duodénale → intolérance alimentaire avec vomissements précoces non bilieux - Fistule bilio-biliaire : fistulisation de la vésicule biliaire ou de la voie biliaire 2^{ndr} avec la voie biliaire principale
	Lithiasse intra-hépatique	= Présence d'une lithiasse en amont de la convergence biliaire - Manifestations : asymptomatique ou ictère, cholestase + cytolyse - Complication : angiocholite récidivante (malgré cholécystectomie), cirrhose biliaire → Tumeur hépatique sous-jacente fréquente - Bili-IRM = référence : état de l'arbre biliaire, nombre de lithiasse - TTT selon le nombre de lithiasses et l'état du parenchyme hépatique sous-jacente : abstention thérapeutique, dissolution médicale à l'acide ursodésoxycholique, lithotritie ou drainage endoscopique, radiologique ou chirurgicale	